



FICHA DE INGRESO PSIQUIATRÍA INFANTO-JUVENIL

Conforme a normativa chilena – Uso Clínico

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

- Nombre: Benjamín Espinoza
- RUN: 21.535.655-8
- Fecha de nacimiento:
- Edad: 22 años
- Sexo: masculino
- Escolaridad: 1 año trabajo social
- Establecimiento educacional: UCM Curicó
- Nombre del cuidador/tutor legal:
- Contacto:

2. MOTIVO DE CONSULTA

- Descripción del motivo de consulta: no tiene claridad, refiere que fue derivado desde PARI, presenta síntomas del ánimo
- Tiempo de evolución: Historia de enfermedad hereditaria en estudio, sin lograr diagnóstico desde hace años, que implica patologías como HTA, DM, síncope frecuentes, enfermedad hepática avanzada, tiene prohibido tomar fármacos, debe bajar de peso para ser candidato a trasplante (madre y tíos además presentes ACV a repetición, cáncer temprana edad y leucemias). En 3 ocasiones hospitalizado por síncope, sin llegar a diagnóstico. LLeva 7 años con síntomas de síncope que son muy invalidantes.
- Benjamín actualmente cursa la carrera de Trabajo Social, va en primer año, la cual eligió como segunda opción tras no alcanzar el puntaje para Medicina. Actualmente, a pesar de sus síncope y problemas médicos, mantiene buen rendimiento académico, aunque sus procesos de aprendizaje han sido más lentos debido a hospitalizaciones y motivos médicos. Ha tenido problemas en trabajos en grupo, ya que sus compañeros no comprenden sus ausencias por urgencias médicas.
- Por otra parte, él no desea que sientan pena por él, por lo tanto, no comunica sus dificultades ni a sus compañeros ni a sus jefes de carrera. Refiere no quiere que le entreguen las cosas fáciles. Sí presenta adecuaciones curriculares, aunque manifiesta resistencia a usarlas por no querer recibir un trato diferente. Dice presentar sentimientos de desánimo, agotamiento físico debido a los constantes procedimientos médicos,

estudios frecuentes y de larga data y la falta de un diagnóstico claro tras años de estudio.

- Menciona la presencia de ideación suicida en el pasado, específicamente más hace cuatro años. Actualmente, refiere desear alivio frente al sufrimiento más que morir. Nunca ha presentado ideación suicida estructurada. Refiere su psicólogo lo ha ayudado mucho, con quien lleva tres años de seguimiento. Lo ha ayudado a aprender a vivir con su enfermedad. Ve a su psicólogo una vez al mes. Actualmente, además, se encuentra con dieta estricta, ya que debe bajar aproximadamente setenta kilos, ya que pesó-- llegó a pesar ciento cuarenta kilogramos, para poder ser candidato a trasplante hepático.
- Se indaga cómo se autorregula cuando presenta pena o mucha angustia. Prefiere que se refugie en su familia, se... come algo. Por otra parte, refiere que hubo una etapa en donde habría pensado dejar de estudiar o bien congelar sus estudios. Dice lo conversa en extenso con su madre, ya que al principio se encontraba muy motivado por la carrera, ya que tiene mucha vocación. Él, al igual que su familia, disfrutan ayudar a las personas.
- Menciona ocasiones en donde junto a su familia han ayudado a vecinos o a personas con necesidades, y esto le hace muy bien. Por lo tanto, su carrera le entusiasma mucho. Conversa en extenso con su mamá, en donde llegan a la conclusión de continuar, ya que madre a su edad tenía muchos síntomas y actualmente han cedido varios de estos. Por lo tanto, presenta esperanza de que su salud pueda mejorar o evolucionar mejor.
- Se solicita a Benjamín que pida al hospital un certificado o documento que acredite que su enfermedad se encuentra en estudio para poder apoyar con un documento en donde se puedan justificar pausas o inasistencias. Benjamín impresiona terapeado, ya que refiere que llega a la conclusión de que él probablemente logrará terminar sus estudios, pero a un ritmo diferente que los demás. Impresiona lo ha elaborado y está dispuesto a vivir su proceso universitario en otros tiempos diferentes a los habituales.
- A nivel social es más bien solitario, pero pasa bastante tiempo con su familia. Reporta que actualmente se encuentra enfermo, por lo tanto, de bajo ánimo, ya que no ha podido salir ni hacer cosas de su interés. Impresiona importantes características de resiliencia personal. Se programa una nueva sesión de control para septiembre con el objetivo de monitorear su estado emocional actual y realizar ajustes necesarios en su acompañamiento o bien justificar pausas o recesos en estudios universitarios. Refiere estar de acuerdo

3. ANTECEDENTES PSIQUIÁTRICOS PERSONALES

- Diagnósticos previos: t. adaptativo
- Hospitalizaciones previas: no de salud mental
- Tratamientos farmacológicos: no
- Psicoterapia previa: si desde hace 3 años, acompañamiento ps, buen vínculo
- Conductas autolesivas / ideación suicida: no y no

4. ANTECEDENTES MÉDICOS GENERALES

- Patologías médicas relevantes: enfermedad hereditaria en estudio, sin lograr diagnóstico desde hace años, que implica patologías como HTA, DM, síncope frecuentes, enfermedad hepática avanzada, tiene prohibido tomar fármacos, debe bajar de peso para ser candidato a trasplante (madre y tíos además presentes ACV a repetición, cáncer temprana edad y leucemias). En 3 ocasiones hospitalizado por síncope, sin llegar a dg.
- Tratamientos actuales: tiene contraindicado todo tipo de fármacos por daño hepático
- Alergias: no

5. ANTECEDENTES FAMILIARES

- Antecedentes psiquiátricos familiares: no conocidos
- Contexto psicosocial relevante: vive actualmente con madre y hermanos, padre maltratador separado de madre, se niega a ser donante de hígado de Benjamín

6. EVALUACIÓN DEL ESTADO MENTAL

- Apariencia: constitución mesomorfa, acorde a edad cronológica, vestimenta e higiene adecuada
- Actitud: cooperador, pueril
- Psicomotricidad: se observa normal, poco evaluable debido a que debe apagar cámara por mala señal
- Lenguaje: Notificativo, atinente, sin alteraciones en estructura. Impresiona enlentecido lenguaje y pensamiento.
- Pensamiento: Sin alteraciones formales, niega delirios y niega alteraciones sensorio-perceptuales hoy. Contenido en relación a duelo por enfermedad y episodios de desesperanza vital por ciertos periodos.
- Ánimo: impresiona deprimido
- Contacto visual: adecuado
- Juicio de realidad: conservado, no psicótico.
- Insight: parcial

7. EVALUACIÓN DE RIESGO

- Riesgo suicida: no actualmente
- Factores de riesgo: enfermedad crónica con diagnóstico y pronóstico incierto que genera alteración de su funcionamiento diario e inestabilidad emocional, probable deterioro funcional progresivo en paciente joven. Historia de maltrato paterno.
- Factores protectores: buena red de apoyo familiar, altruismo como sentido de vida, factores de resiliencia propios, buen vínculo materno, estudios universitarios.

8. IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA (DSM-5 / CIE-11)

- Diagnóstico principal: t. adaptativo crónico
- Diagnósticos secundarios: daño cognitivo??

9. PLAN TERAPÉUTICO

- Tratamiento farmacológico: no puede tomar fármacos por enfermedad médica.
- Intervenciones psicosociales: apoyo en crear plan de crisis, activar redes de apoyo, se indica importancia de mantener acompañamiento psicológico.
- Derivaciones:

Mantener psicoterapia

Solicitar pausas o recesos en estudios universitarios por motivos médicos en caso de necesidad

Acompañamiento en SOS

10. SEGUIMIENTO

- Fecha próximo control: septiembre 2026
- Red de apoyo: familia materna
- Indicaciones a cuidadores: mayor de 18 años

11. DATOS DEL PROFESIONAL

Nombre: Caterina Schiappacasse Arteaga

Especialidad: psiquiatra infanto juvenil

Registro profesional: 105595

Centro de atención: Psicoeduka Santiago

Fecha: 21 julio 2026